



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : محمود محمد حمدي بكر
المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : الخانكة
رقم البطاقة : 26506020101571 رقم التليفون : 01101778502
العنوان : // تاريخ تسجيل الإستمارة : 30-09-2026
العمر (تاريخ الميلاد) : 02-06-1965 المهنة : بدون عمل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : ورم بالمخ والغدة النخامية
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : ورم بالمخ والغدة النخامية
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج داعم وتلطيفي ودوائي [7090] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن الوظيفة: ----- التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان الوظيفة: ----- التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / ----- أ.د. / ----- أ.د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- قسم : -----
جهة العلاج : ----- نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: محمود محمد حمدي بك National ID: 26506020101571	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

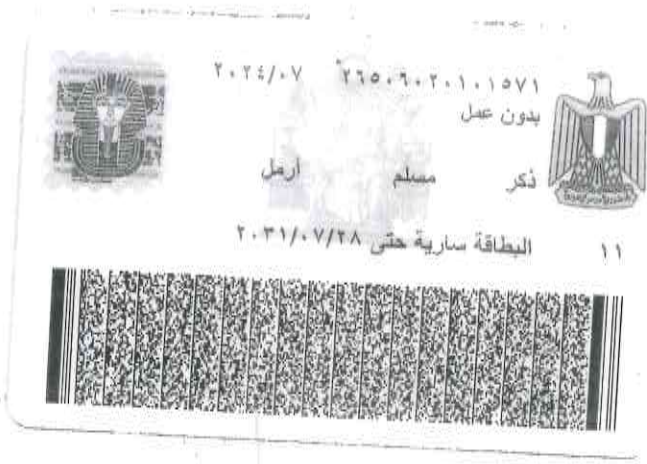
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

A patient of brain and central nervous system cancer for Supportive and palliative medical management.
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Fundus photography

Name: Mahmmoud Mohammed Hamdy

Date: 13/11/2025

Fundus photography was done for both eyes, and revealed:

OU:

- Optic disc is well defined with normal color and C/D ratio: 0.2.
- Macular background shows normal appearance.
- Retinal blood vessels looks normal regarding their caliber and branching pattern.
- Tortuous veins

Much Obligated

AL/ Ola Nasser

Assistant Lecturer of ophthalmology ASU

بنت حمدي
11/10
ش. ناصر

Ainshams University Hospitals

Ocular Investigations Unit

Optical Coherence Tomography



Name	Eye	Date
Mahmoud Mohamed Hamdy	OU	13 November 2025

OCT of the Right eye shows:

- Average GCC thickness is **91 um (within normal thickness)**.
- Average RNFL thickness is **89 um (within normal thickness) with within normal thickness in all quadrants.**
- **Preserved** bi-hump sign and ISNT rule.
- Average C/D ratio **V 0.36, H 0.45**
- **Rim area = 1.99 mm².**

OCT of the Left eye shows:

- Average GCC thickness is **89 um (within normal thickness)**.
- Average RNFL thickness is **87 um (borderline) with within normal thickness in all quadrants.**
- **Preserved** bi-hump sign and ISNT rule.
- Average C/D ratio **V 0.50, H 0.47**
- **Rim area = 1.80 mm².**

Impression:

OD: Within normal GCC & peripapillary RNFL thickness.

OS: Within normal GCC & borderline peripapillary RNFL thickness.

Much Obligated,
Yousef A. Fouad, MD, FRCS (Glasg.)
Lecturer of Ophthalmology



Patient Name	محمود محمد مصطفى بكر	PID	1021022521 7008	D/T	04-10-2025
--------------	----------------------	-----	--------------------	-----	------------

CT Cerebral Angiography

Axial contiguous cuts were taken through the cerebral arteries after intra-venous contrast injection with MIP and MPR images.

- ✗ Sellar and suprasellar non-enhancing soft tissue lesion is noted measuring 2.3x1.4 cm with encasement of right cavernous sinus and subsequent mild attenuation of cavernous segment of right ICA. Other segments of right ICA are seen patent of average caliber.
- ✗ Normal course, caliber and branching of left internal carotid arteries and the vertebro-basilar system and their branches, with no vascular anomalies, aneurysms, stenotic segments, occlusions or deviations.
- ✗ No evidence of abnormal arterial dissection or peri-arterial hematoma or collection.
- ✗ No calcification seen, with no evidence of soft tissue or calcified plaques.

Opinion:

- Picture suggestive of right sellar and suprasellar macroadenoma with mildly attenuated cavernous segment of right ICA for dedicated MRI sellar study .

Mona Abdelaziz MSc

Ain Shams University Hospitals Radiology department



مستشفيات جامعة عين شمس
قسم الأشعة التشخيصية

Patient Name	محمود محمد حدى بكر	PID	1021022521 7008	D/T	05-10-2025
--------------	--------------------	-----	--------------------	-----	------------

C.T. SCAN OF THE ORBITS WITHOUT CONTRAST

- ✗ Normal C.T. appearance of orbital structures with no intra or extra-orbital masses.
- ✗ Intact bony boundaries of the orbits, with normal orbital foraminae.
- ✗ Both eye globes are normal in size.
- ✗ The extra-ocular muscles are normal in thickness on both sides.
- ✗ No focal orbital masses.
- ✗ Normal course and calibre of both optic nerves.

NB; Sellar lesion is noted extending to right sphenoid sinus, for MRI assessment.

Opinion:

- ✗ *Unremarkable CT study of the orbit.*

Ahmed Hussein, MSc.



Patient Name	محمود محمد مصطفى بكر	PID	1021022521 7008	D/T	06-10-2025
--------------	----------------------	-----	--------------------	-----	------------

MRI EXAMINATION OF THE SELLA TURCICA AND CAVERNOUS SINUS PROTOCOL

Findings:

- Sellar and supra sellar SOL measuring 2.8 x 2.8 cm in CC x TR diameters invading the right cavernous sinus encasing cavernous segment of ICA which maintains average caliber and signal void. Extension to the right Meckel's cave obliterating the anterior aspect.
- Medial wall of left cavernous sinus is inseparable from the pituitary mass, however no definite left sided infiltration.
- Optic chiasm is significantly elevated by the mass effect, with cranial extension to the supra-sellar cistern displacing anterior communicating artery and A1 segments of anterior cerebral arteries.
- Mass effect is noted upon the cisternal course of the right oculomotor nerve.
- Caudal extension through the sellar floor encroaching upon the right sphenoid sinus.
- Complementary T2 of the brain reveals mild peri-ventricular chronic ischemic changes associated age matched involutional brain changes with exaggerated sulci and prominent ventricular cistern.

Opinion:

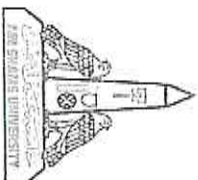
- Sellar and supra-sellar SOL invading the right cavernous sinus with extensions and relation to neurovascular structures as described.

Dr.Tougan Taha,MD

Email : feedbackradiology@gmail.com

مستشفيات جامعة عين شمس - شوارع رمسيس - الجلسية القاهرة

Ain Shams University Hospitals Radiology department



مستشفيات جامعة عين شمس
قسم الأشعة التشخيصية

Patient Name	محمود محمد حمدي بكر	PID	1021022521 7008	D/T	07-10-2025
--------------	---------------------	-----	--------------------	-----	------------

CT SCAN OF THE BRAIN :-

- ✗ Mild subvolumic brain changes in the form of mildly dilated ventricles , prominent cortical sulci and widened subarachnoid spaces
- ✗ Normal C.T. density of the brain parenchyma, with no focal lesions on non-contrast basis
- ✗ No midline shift.
- ✗ No intra-cerebral or extra axial hematoma or fluid collection.
- ✗ Normal posterior fossa structures by CT criteria.
- ✗ No definite skull fractures.

Rewan Ahmed, MSc

Email : feedbackradiology@gmail.com

مستشفيات جامعة عين شمس - شارع رمسيس - العباسية القاهرة

Ain Shams University Hospitals
Radiology departmentمستشفيات جامعة عين شمس
قسم الأشعة التشخيصية

Patient Name	محمود محمد حصى بكر	PID	1021022521 7008	D/T	30-09-2025
--------------	--------------------	-----	--------------------	-----	------------

MRI BRAIN (STROKE PROTOCOL):Findings:

- *Sellar and suprasellar soft tissue lesion is noted seen encasing the right cavernous ICA with subsequent mild attenuation for assessment by MRI sella protocol.*
- *No recent infarcts or hemorrhages.*
- *Areas of altered signal (High T2/FLAIR low T1 SI, with no true diffusion restriction) are present in*
 - *Bilateral periventricular & deep white matter consistent with arteriosclerotic ischemic leukoencephalopathy*
 - *Mild subvolumic brain changes in the form of widened sulci and with mildly dilated ventricular system.*
- *No shift of midline structures.*
- *No intra or extra axial hematoma.*
- *Normal MRI appearance of cerebellum, brainstem, CPAs & pituitary gland.*

MRA:

- *Mildly attenuated cavernous segment of right ICA.*
- *Mild Diffuse atherosclerotic changes of the anterior and posterior circulation in the form of beading of peripheral & terminal branches.*
- *No large aneurysm or AVM could be detected.*
 - *Normal Variants: hypoplastic right vertebral artery.*

OPINION:

- *Sellar and suprasellar soft tissue lesion with mild attenuation of the right cavernous ICA for assessment by MRI sella protocol.*
- *Mild subvolumic brain changes and arteriosclerotic leukoencephalopathy as described.*

Best Regards

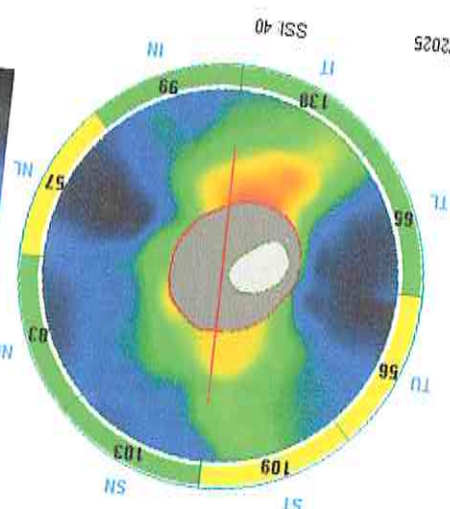
Mona Abdelaziz, MSc

ONH/GCC OU Report

Right / OD

GCC NDB Reference

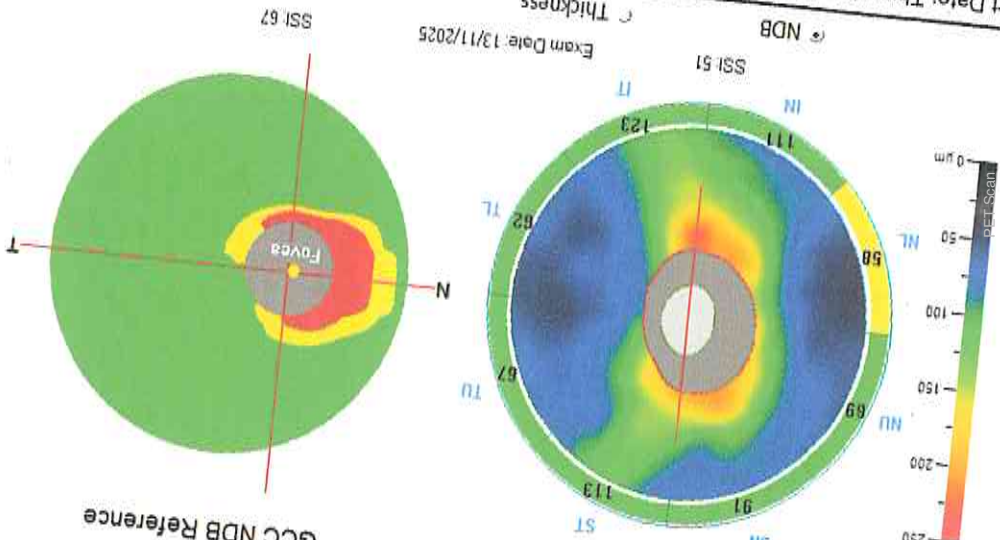
Optic Nerve Head Map



Exam Date: 13/11/2025

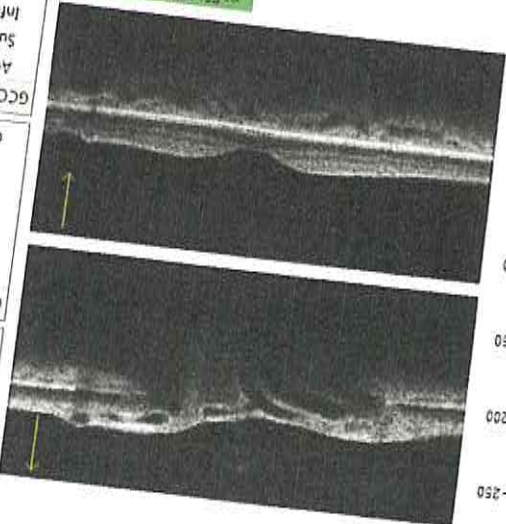
Left / OS

Optic Nerve Head Map



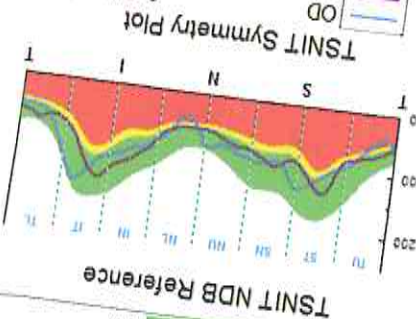
Exam Date: 13/11/2025
 Thickness

Software Version: 2018.1.1.63

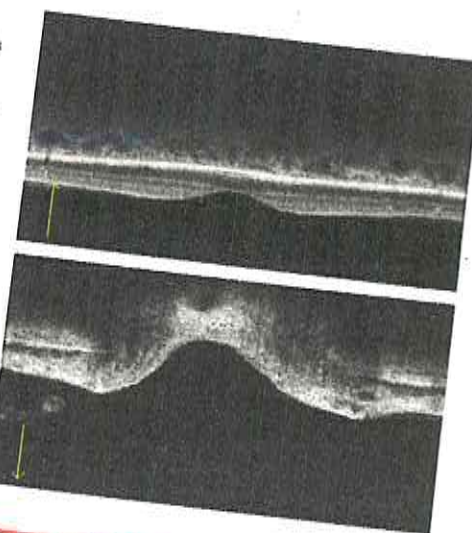
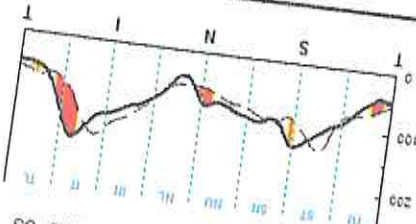


p<5% Within Normal
 p<1% Outside Normal

Summary Parameters	
RNFL Analysis	
Average RNFL (um)	89
Superior RNFL (um)	87
Inferior RNFL (um)	85
Intra Eye (S-I) (um)	2
OD	OS
Inter Eye (OD-OS)	N/A
ONH Analysis	
Cup/Disc Area Ratio	0.17
Cup/Disc V. Ratio	0.36
Cup/Disc H. Ratio	0.45
Rim Area (mm²)	1.89
Disc Area (mm²)	2.41
Cup Volume (mm³)	0.036
OD	OS
Inter Eye (OD-OS)	-0.108
GCC Analysis	
Average GCC (um)	91
Superior GCC (um)	88
Inferior GCC (um)	95
Intra Eye (S-I) (um)	-7
FLV (%)	3.22
GLV (%)	5.24
OD	OS
Inter Eye (OD-OS)	-0.96



Solid line - OD
 Dash line - OS



[[DOCTYPE:PET_SCAN]]